

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

ursodeoxycholic acid 70ml, 140ml
(유스뉴로솔루션, (주)유스팜)

- ☐ 제형, 성분·함량 :
 - 140ml 중 ursodeoxycholic acid 3.5g
- ☐ 효능 효과 :
 - 근위축성측삭경화증(ALS) 환자에서 병의 진행을 늦추어 준다.
- ☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일
2012년 제13차 약제급여평가위원회 : 2012년 11월 22일
2013년 제 4차 약제급여평가위원회 : 2013년 4월 18일 [재평가]
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2012년 11월 12일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 심의결과(2013년 제 13차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “근위축성측삭경화증(ALS) 환자에서 병의 진행을 늦추어 준다.”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 임상적 유용성을 입증하는 근거가 부족하고, 소요비용이 대체 약제보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여 함

□ 최종결과

○ 기심의결과 유지(비급여)

- 신청품은 “근위축성측삭경화증(ALS) 환자에서 병의 진행을 늦추어 준다.”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과를 입증하는 근거가 부족하여 임상적 유용성이 불분명하므로 비급여 함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “근위축성측삭경화증(ALS) 환자에서 병의 진행을 늦추어 준다.”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 riluzole이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ursodeoxycholic acid 성분의 액제로, 근위축성 측삭경화증(ALS) 환자에서 병의 진행을 늦추어 주는 목적으로 사용하도록 허가받았음
- 해당 적응증의 사용에 신청품이 언급된 가이드라인은 검색되지 않음
- 근위축성 측삭경화증으로 진단 받은 환자(n=63)를 대상으로 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 교차투여(period 1/2) 임상시험을 8개월 동안 수행한 결과(PP 분석)¹⁾, period 1 또는 2에 한번 이상 UDCA를 투여한 신청품군(n=25)에서의 AALSRS²⁾의 기울기는 위약군(n=28)에 비해 1.17 point/month 낮았음(2.3 vs. 3.47 points/month, 95% CI for difference 0.08-2.26, p=0.037)
- Period 1 또는 2에 한번 이상 UDCA를 투여한 신청품군(n=48)에서 ALSFRS-R³⁾ 기울기는 위약군(n=44)과 통계적으로 유의한 차이 없었고(-1.04 vs -1.61, 95% CI for difference -1.37-0.23, p=0.16), FVC(%)⁴⁾에서 두 군 간 유의한 차이를 보이지 않았

음(-1.76 vs -2.52, 95% CI for difference -4.04-2.52, p=0.62)

- 신청품군 70명 중 17명(23%)에서 25건, 위약군 74명 중 10명(14.3%)에서 12건의 이상반응이 발생하였고, 위장관계 이상반응은 신청품군에서 18건으로 위약군 6건 대비 유의하게 높은 빈도로 발생하였음(p<0.05)
 - 동 문헌에 언급된 고찰에 따르면, 임상시험에 참여한 환자의 탈락률, 분석 방법 및 임상시험 기간 등 한계점으로 인해 ALS의 치료로 UDCA를 투여 시 효과에 대한 명확한 결론을 내리기 어려움
- 임상시험 디자인 및 결과에 따르면 신청품은 치료적 유효성을 입증할 수 있는 근거가 부족한 약제이며⁵⁾⁶⁾, 기심의 후 추가적인 임상근거자료는 제출되지 않았음⁷⁾

○ 비용 효과성

- 근위축성측삭경화증의 근본적인 병리 과정을 막을 수 있는 치료법은 없으며, 질환의 진행을 늦추는 효과를 나타내는 약제인 riluzole을 대체약제로 선정함⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾
- 신청품은 대체약제 대비 상대적 임상적 유용성이 불분명하며, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■■■원으로 대체약제 1일 소요비용과 동일함

○ 재정 영향¹²⁾

- 해당적응증의 대상 환자수¹³⁾는 약 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■이 되고, riluzole과 동일가이프로 riluzole의 대체로 재정소요금액은 없을 것으로 예상됨
- 제약사에서는 대체약제인 riluzole의 2012년도 원료의약품 수입가를 기준으로 환자수를 추정하여 실제 riluzole의 청구 환자수와 차이가 있으므로 제시된 예상사용량은 과소 추정되었을 가능성이 있으며, riluzole 시장을 100% 대체한다고 가정하였으므로 재정 영향이 달라질 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가에 등재되어 있지 않음

Reference

- 1) Min J-H et al. Oral solubilized ursodeoxycholic acid therapy in amyotrophic lateral sclerosis: A randomized cross-over trial. J Korean Med Sci 2012;27:200-206
- 2) Appel ALS Rating Scale: AALSRS은 5개의 하부 점수(연수, 호흡기, 근강도, 하지 및 상지기능)로 구성되며, 정상인 경우 30점, 최악의 기능 장애를 가진 환자는 164점으로 산출됨. AALSRS 점

수의 변화 속도는 ALS 환자의 생존에 있어 유의한 예측 인자임

- 3) revised-ALS Functional Rating Scale: 12 종류의 기능적 활동 능력 및 독립성 평가를 위해 사용하는 지표로, 연수, 호흡기, 상지 및 하지 기능 등에 대한 평가를 실시하며, 정상인 경우 48점, 최악의 기능 장애인 경우 0점으로 산출됨,
- 4) Forced Vital Capacity: ALS 질환에서 호흡기 장애를 나타내는데 사용되는 호흡기능에 관한 지표로 사망률과 기관 절개에 대한 예후 예측인자임
- 5) 대한신경과학회
- 6) 중앙심사평가조정위원회(2012.11.12)
- 7) 건강보험심사평가원 상근심사위원 자문(2013.4.17.)
- 8) Harrison's Internal Medicine 18th ed.
- 9) Goldman's Cecil Medicine 24th ed.
- 10) Goodman&Gilman's the pharmacological basis of therapeutics
- 11) EFNS guidelines on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis 2012. revised report of an EFNS task force
- 12) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 13) 2011년 riluzole을 청구한 환자수
- 14) 제약사제출 예상사용량
※ 제약사 제출 예상환자수:
- 16) 절대재정소요금액 = 제약사제시 품목별 예상사용량 x 신청약가